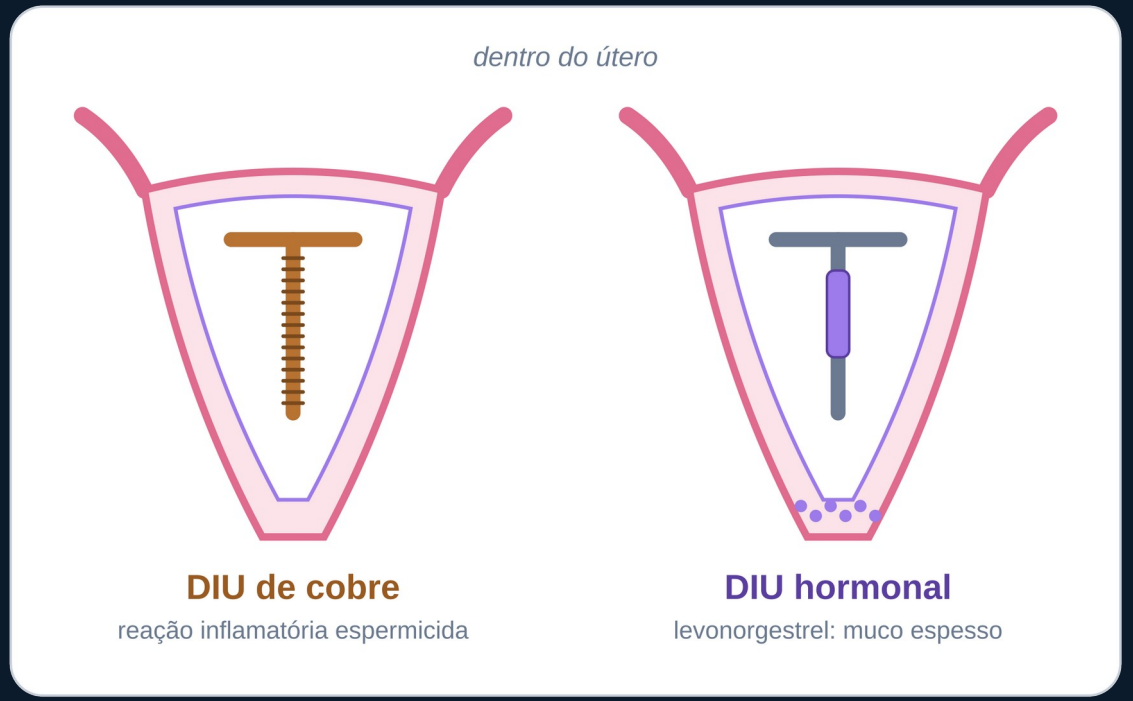
Métodos anticoncepcionais

Aula 6 · Unidade V

Como se evita uma gravidez: do ciclo menstrual à escolha do método certo para cada pessoa.

2 horas



Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa
Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

ROTEIRO DE HOJE

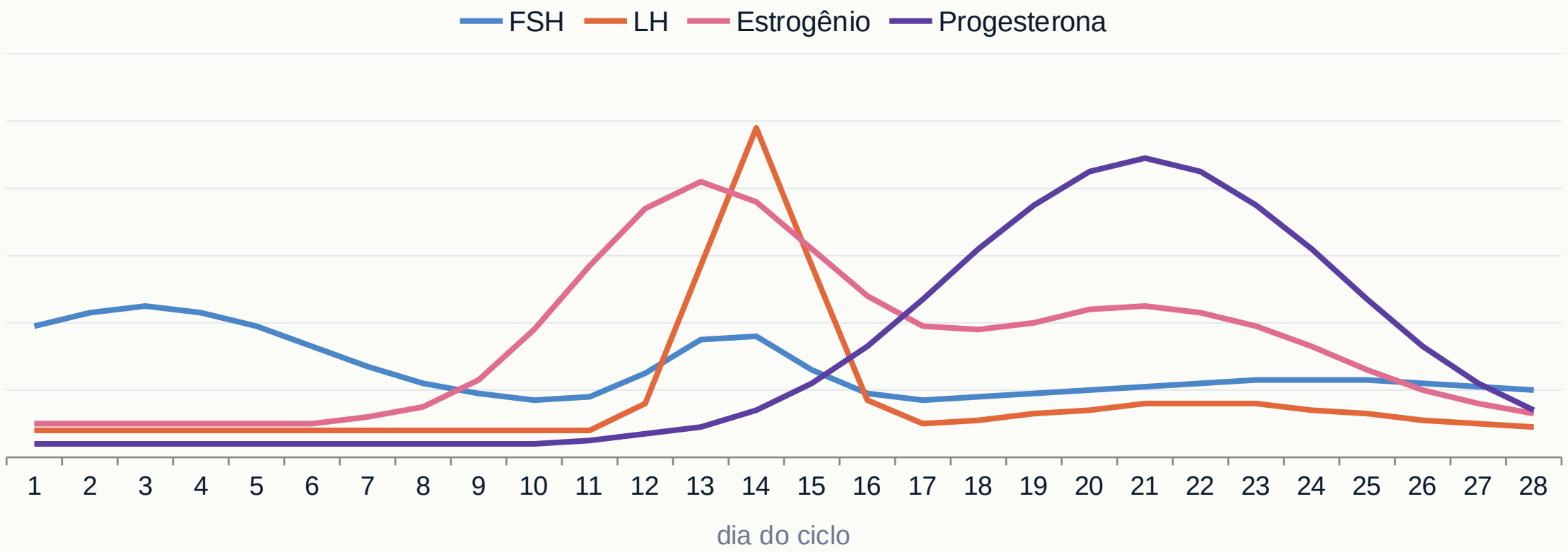
Ao final da aula você vai saber

1. **Classificar**
   os métodos pelo mecanismo: comportamental, barreira, hormonal, DIU e definitivo

2. **Relacionar**
   cada método com a fisiologia do ciclo que já estudamos

3. **Discutir**
   como escolher um método segundo eficácia, reversibilidade e perfil da pessoa

O ciclo em 28 dias: quem manda em quem



Pico de LH no dia 14 dispara a ovulação. Hormonal de fora = sem pico de LH = sem ovulação.

Feedback negativo: o freio que os hormonais usam

Hipotálamo
libera GnRH

→

Hipófise
libera FSH e LH

→

Ovário
produz estrogênio e progesterona

→

Útero
endométrio se prepara para a nidação

Estrogênio e progesterona altos "avisam" o cérebro para frear GnRH, FSH e LH. Hormônio de fora = freio acionado.

CLASSIFICAÇÃO

Cinco categorias de métodos

Comportamentais

dependem do casal e do período fértil

Barreira

bloqueio físico do encontro dos gametas

Hormonais

inibem a ovulação e espessam o muco

DIU

dispositivo dentro do útero

Definitivos

cirurgia: laqueadura e vasectomia

MÉTODOS COMPORTAMENTAIS

Tentar identificar o período fértil

Tabelinha (Ogino-Knaus)

calcula a janela fértil pela duração dos ciclos anteriores

Temperatura basal

a progesterona eleva discretamente a temperatura após a ovulação

Muco cervical (Billings)

perto da ovulação o muco fica transparente e filante, como clara de ovo

Coito interrompido

retirada antes da ejaculação; baixa eficácia

POR QUE FALHAM MAIS?

A ovulação varia de ciclo para ciclo

Comportamentais

dependem de prever a ovulação, que se desloca com estresse, doenças e irregularidades. O espermatozoide ainda sobrevive dias no trato feminino.

Hormonais

suprimem a ovulação de forma farmacológica e eliminam a variabilidade.

Discursiva 3 da apostila: comportamentais dependem da previsibilidade do ciclo; hormonais suprimem o eixo.

MÉTODOS DE BARREIRA

Bloqueio físico e proteção contra IST

Preservativo masculino e feminino

impedem o contato; protegem de IST

Diafragma

cobre o colo do útero; usado com espermicida

Capuz cervical

menor, encaixa sobre o colo

Único que protege de IST

o preservativo; por isso a dupla proteção

Dupla proteção: preservativo + outro método de alta eficácia.

Dois mecanismos principais

1. Inibem a ovulação

feedback negativo sobre hipotálamo e hipófise: sem pico de LH

2. Espessam o muco cervical

tampão que dificulta a passagem dos espermatozoides

Pílula combinada: sobretudo inibe a ovulação. Minipílula: sobretudo espessa o muco.

Quem é quem nos hormonais

Método	Hormônios	Detalhe
Pílula combinada	estrogênio + progestagênio	inibe a ovulação
Minipílula	só progestagênio	espessa o muco; boa na lactação
Injetáveis	combinado ou só progestagênio	mensal ou trimestral
Implante subdérmico	progestagênio	dura até 3 anos
Anel vaginal e adesivo	hormônios combinados	vias alternativas de liberação

CASO CLÁSSICO DE PROVA

Lactante: por que a minipílula?

Pílula combinada

o estrogênio pode reduzir a produção de leite

Minipílula

só progestagênio: sem efeito significativo sobre a lactação

Discursiva 4 da apostila: o estrogênio pode reduzir o leite; a minipílula não tem estrogênio.

SEGURANÇA

Quando evitar o estrogênio

Tabagistas acima de 35 anos

risco cardiovascular aumentado

Hipertensas graves

pressão alta descontrolada

História de trombose

o estrogênio favorece a coagulação

Alternativas sem estrogênio: minipílula, implante, DIU, barreira.

CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA

A "pílula do dia seguinte"

O que é

dose alta de progestagênio (levonorgestrel)

Como age

retarda ou inibe a ovulação

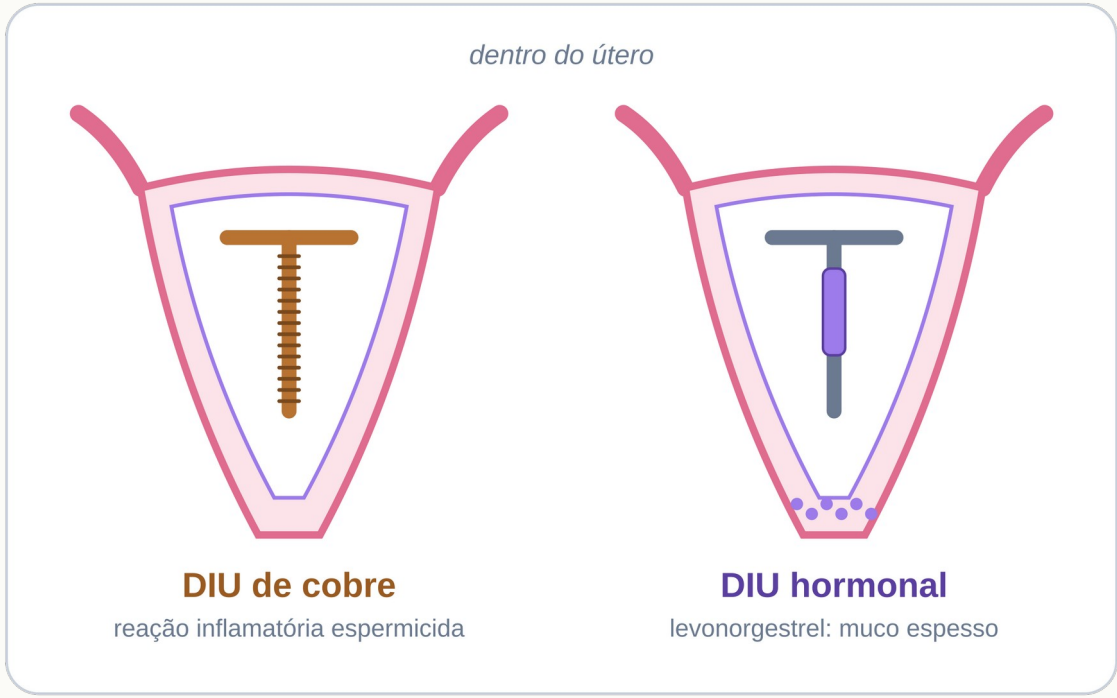
NÃO é abortiva

se já houve implantação, não interrompe a gestação

Uso

excepcional; quanto mais cedo, melhor

Dispositivo dentro da cavidade uterina

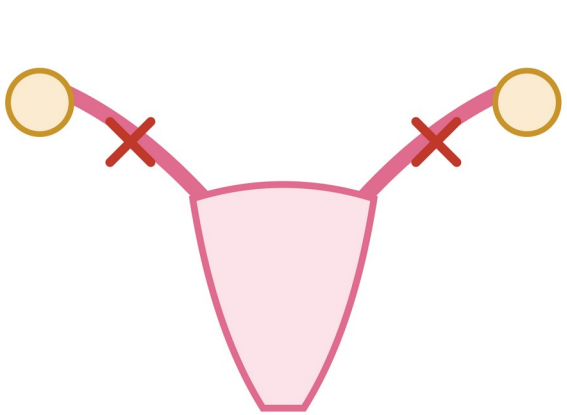


1. **DIU de cobre**
   sem hormônio; reação inflamatória local que é tóxica ao espermatozoide

2. **DIU hormonal**
   libera levonorgestrel: espessa o muco e atua na ovulação

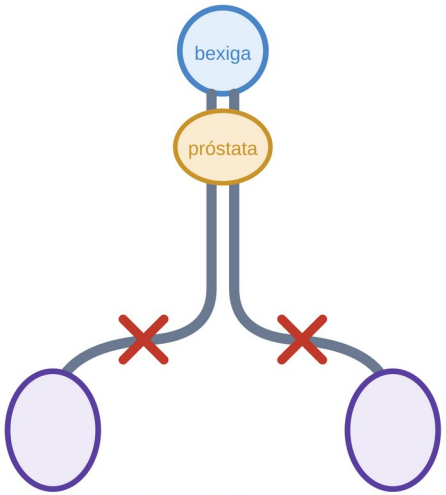
3. **Eficácia muito alta**
   e reversível: retirou, a fertilidade volta

Cirurgia que interrompe a via dos gametas



Laqueadura

tubas ligadas ou seccionadas



Vasectomia: ducto deferente seccionado

1 **Laqueadura**
tubas uterinas ligadas ou seccionadas

2 **Vasectomia**
ductos deferentes seccionados; o ejaculado sai sem espermatozoides

3 **Atenção**
testosterona e ereção não mudam; pouco reversíveis

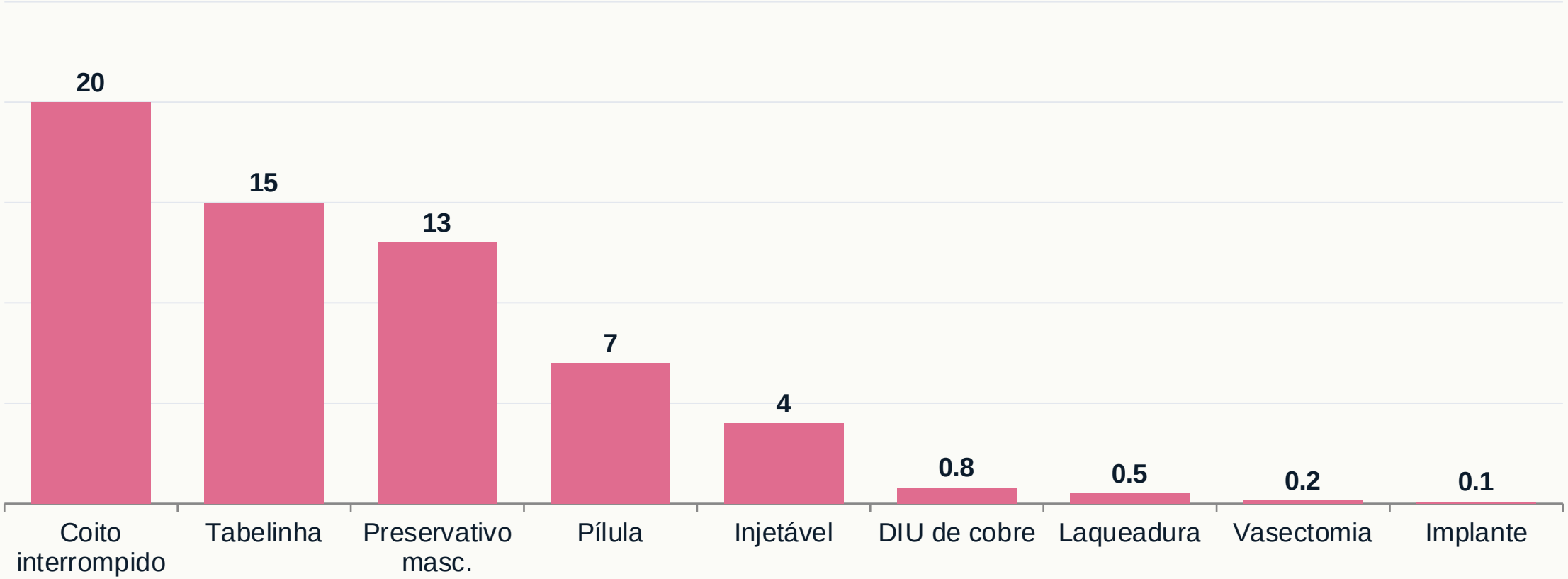
QUADRO-RESUMO

Os cinco grupos lado a lado

Grupo	Mecanismo	Protege de IST?	Eficácia
Comportamentais	calculam o período fértil	Não	baixa
Barreira	bloqueio físico	Sim (preservativo)	moderada a alta
Hormonais	inibem ovulação, espessam muco	Não	alta
DIU	ação local ou hormonal	Não	muito alta
Definitivos	interrupção cirúrgica	Não	muito alta

EFICÁCIA

Quantas em 100 engravidam em 1 ano? (uso típico)



Valores aproximados, só para comparar ordens de grandeza. Índice de Pearl = gestações por 100 mulheres-ano.

COMO ESCOLHER

Não existe "o melhor": existe o mais adequado

1. **Eficácia**
   quanto o método falha no uso real

2. **Reversibilidade**
   a pessoa quer ter filhos no futuro?

3. **Contraindicações**
   tabagismo, hipertensão, trombose

4. **Praticidade e custo**
   rotina, acesso, disponibilidade no SUS

5. **Proteção contra IST**
   preservativo, sozinho ou em dupla proteção

POR QUE ISSO IMPORTA NA FISIOTERAPIA

Quatro ligações com a prática

Saber o que a paciente usa

faz parte da anamnese

Alerta de trombose

dor e edema unilateral na panturrilha em usuária de estrogênio: não mobilizar, encaminhar

Pós-parto

puérperas perguntam sobre métodos; encaminhar bem

Autonomia e sigilo

informar sem julgar

ATIVIDADE · 30 MINUTOS

Estudo de caso e role-play

Em grupos: 15 min para preparar, 3 min para apresentar. Um faz o profissional, outro a paciente, outro observa. Recomende e justifique pela fisiologia.

1. Perfil 1: adolescente sem parceiro fixo
2. Perfil 2: mulher lactante
3. Perfil 3: mulher com contraindicação a estrogênio
4. Perfil 4: casal que deseja método definitivo

ORIENTAÇÕES PARA A DISCUSSÃO

Uma possível resposta por perfil

1. Adolescente

preservativo, idealmente com outro método (dupla proteção)

2. Lactante

minipílula: sem estrogênio, não reduz o leite

3. Sem estrogênio

só progestagênio ou DIU de cobre

4. Método definitivo

vasectomia ou laqueadura, com aconselhamento sobre irreversibilidade

QUIZ RELÂMPAGO

Três perguntas da apostila

1. O único método que também previne IST:

A) Pílula combinada

B) DIU hormonal

C) Preservativo

D) Laqueadura

2. Mecanismo do DIU de cobre:

A) Inibe a ovulação

B) Reação inflamatória local espermicida

C) Bloqueia o eixo hipotalâmico

D) Impede a ereção

3. A vasectomia:

A) Suprime a testosterona

B) Impede espermatozoides no ejaculado

C) Impede a ereção

D) Elimina o sêmen

RESPOSTAS

Gabarito

Questão 1: C

Preservativo: contracepção e prevenção de IST.

Questão 2: B

O cobre gera reação inflamatória tóxica ao espermatozoide.

Questão 3: B

O sêmen sai sem espermatozoides.

Para estudar em casa (discursivas)

Por que os métodos comportamentais são menos eficazes que os hormonais?

Por que a minipílula é preferida na lactação?

PARA LEVAR

Cinco ideias para guardar

1. **Cinco categorias**
   comportamental, barreira, hormonal, DIU, definitivo

2. **Hormonais**
   inibem a ovulação (feedback negativo) e espessam o muco

3. **Só o preservativo**
   protege contra IST

4. **DIU de cobre**
   espermicida local, sem hormônio

5. **Escolha**
   eficácia, reversibilidade, contraindicações e perfil

Para estudar mais

- Apostila de Embriologia 2026, Curso de Fisioterapia. Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa.
- MAIA, G. D. Embriologia humana: texto básico para os cursos de ciências da saúde. São Paulo: Atheneu, 2005.
- MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
- COCHARD, L. R. Atlas de embriologia humana de Netter. Porto Alegre: Artmed, 2003.